

Fecha Última Actualización: 11-01-2023 13:07:51

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Francisco Javier Vargas Romero
Edad : 46a 2m 5d
Dirección : Las Cabras Durazno Chico Snumero

Rut : 13.085.475-3
Fecha Nacto: 06/11/1976
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9732241
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 5918 8402

N° Epicrisis
337023

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 18/12/2022 21:45

Días Estadía : 24

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 11/01/2023 12:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia + disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICINA INTERNA

Antecedentes:

- Mórbitos: HTA, ERC en HD (FAV BI L-Mi-V, última 16/12, diuresis residual 250-500 ml/d), Vasculitis ANCA (+), Síndrome riñón-pulmón, Anemia secundaria
- Quirúrgicos: (-)
- Fármacos: Bisoprolol, Losartán, Nifedipino, Omeprazol, Prednisona, Clonazepam, Furosemida, Calcio
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: (-)

Motivo de Consulta: Compromiso de conciencia + Disnea

Historia de ingreso:

Paciente con los antecedentes descritos, consulta el 18/12 derivado desde Rengo por cuadro de disnea asociado a mala mecánica ventilatoria. Al ingreso se describe con compromiso de conciencia cualitativo, inatento, no siguiendo órdenes simples, sin emisión de lenguaje. Hipertenso con PA hasta 243/143 (162), taquicárdico 100 lpm, Sat 76% ambiental, afebril. En SU se realiza TAC tórax compatible con EPA. TAC de cerebro que se interpreta como PRESS. Posteriormente con evolución tórpida, mala tolerancia a VMNI por lo que requiere IOT en SRI y conexión a VMI. En servicio de urgencia con disminución de PAM a 100 luego de inicio de sedación con Fentanilo/Midazolam por lo que no se inician vasodilatadores EV. Se realiza HD en reanimador de SU con posterior traslado a UPC para continuar estudio y manejo.

Diagnósticos de Ingreso:

1. Insuficiencia respiratoria aguda global:
 - EPA hipertensivo
 - IOT 19/12 - 27/12
2. Compromiso de conciencia en estudio
 - Obs Meningoencefalitis
 - Obs Síndrome encefalopatía reversible posterior (PRESS)
3. Acidosis Metabólica AG normal

Fecha Epicrisis : 11/01/2023 13:07

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

4. Antecedentes: HTA, ERC en HD (FAV BI L-Mi-V, diuresis residual 250-500 ml/d), Vasculitis ANCA (+), Síndrome riñón-pulmón, Anemia secundaria

Evolución hospitalización:

1. HDN: Ingres a con EPA hipertensivo, con buena respuesta inicial a NTG y suspensión precoz, sin requerimientos de DVA. Evoluciona con HTA importante, requiriendo BIC de labetalol, Metildopa y NTG, posterior requerimiento de 6 VDO para manejos de presiones. Evoluciona normotenso, con hipotensión ortostática relacionada a bipedestación durante KNT por lo que se ajustan VDO, actualmente con Carvedilol, Hidralazina e Isosorbide, hoy 11/01 hipertenso por lo que se reinicia Doxazosina y Amlodipino.
2. Respiratorio: Ingres a con IRA global 2° a EPA hipertensivo, sin respuesta a VMNI inicial por lo que requiere IOT para VMI el 19/12. Con buen acople, pero necesidad de reintubación en contexto de agitación. Con sedación a la baja en UPC, evolucionando favorablemente tras HD/UFA y manejo de HTA, se realiza extubación el 27/12 de manera exitosa, pasando a NRC con requerimientos bajos, ambiental desde 28/12, pero con necesidad de aspiraciones en contexto de nuevo hit infeccioso y mal mecanismo de tos que mejora con posición. Dado mejoría clínica y cuadro no compatible, se desestima LBA para descartar hemorragia alveolar. Evoluciona sin conflicto.
3. Nefrológico/Medio Interno: ERC en HMD trisemanal hace 3 años, con antecedente de Sd riñón/pulmón, ANCA (+). Evaluado por Nefrología. se realiza nuevo estudio ANA (-), ANCA (-), Complemento normal, se desestima estudio con Ac anti MB. Seguimiento diario de parámetros nitrogenados, sin urgencia dialítica. Inicialmente con hiperfosfatemia que resuelve con quelantes y HD.
4. Infeccioso: Al ingreso con PCR COVID (-), serologías VHB/VHC/VIH NR, SONI, UC (-), HCs (-). Dado compromiso de conciencia, algunos episodios subfebriles y PCR al alza (sin leucocitosis), se inició manejo empírico con Ceftriaxona/Ampicilina/Aciclovir en dosis meníngea y se realizó PL (20/12): con Citoquímico normal, Gram sin bacterias, PCR VZ/VHS (-), cultivos (-). Evaluado por neurología, se suspenden ATB en dosis meníngea, se mantiene con Ceftriaxona en dosis habitual, que luego se rota a Amp/Sulbactam, sospechando foco respiratorio, completando 7 días, con PPII fluctuantes pero tendencia al descenso. El 27/12 con PCR en ascenso, sin correlato clínico, se decide pancultivar, con CAET (+) a AcBa MS, se inicia Ampicilina Sulbactam a dosis plena, y luego ajuste según función renal. HCs (-) y UC (-). En seguimiento de PPII, con nuevo peak febril el 01/01 por lo que se pancultiva nuevamente (HC, UC, CAET negativos) por lo que se suspende ATB posterior a completar 9 días. Portador de E. faecium VanB. Evoluciona sin conflictos..
5. Neurológico: Ingres a hipertenso severo. Evaluado por neurología con AngioTAC cerebro donde se evidencia hipodensidad occipital bilateral cortical subcortical por lo que se sospecha PRES en relación a emergencia hipertensiva. Control con TC a las 48 horas con mismos signos sugerentes de PRES, en descenso. Con medidas de neuroprotección y disminución paulatina de la PA. RNM de cerebro 03/01 no compatible con PRESS. El 02/01 presenta episodio de mioclonías de pectoral D° + nistagmus y desviación de mirada ipsilateral, a neurología impresiona crisis reactiva a hiperfosfemia severa, se carga en LVT y posterior uso de Ácido Valproico. EEG 03/01 que muestra frecuente lentitud intermitente occipital bilateral sincrónica, sin actividad epileptiforme. Dado resolución de hiperfosfatemia y no presentar nuevas crisis se suspende FAE el 11/01.
6. Oftalmología: evaluado por neurología en contexto de episodio convulsivo, destaca campo visual con defecto bitemporal dudoso, dado antecedente de vasculitis, se solicita evaluación por oftalmología. Evaluado el 06/01, se diagnostica Retinopatía Hipertensiva grado 3 de K-W. Plan de control con retina al alta.
7. ORL: Se solicita IC a especialidad en contexto de disfonía para evaluar compromiso secundario a Vasculitis. Evaluado el 06/01, se realiza NFC con granuloma apófisis vocales obs. post IOT se sugiere IBP en doble dosis por 1 mes (FI 09/01), control NFC con ORL en 2 semanas (20/01 aprox)
- 8 Hematología: en exs 09/01 paciente presenta bicitopenia (Hb 7.1 GB 2470), niega exteriorización de sangrado. AF: madre Ca cuello uterino. Se solicita estudio con perfil hierro con UIBC bajo, ferritina alta, LDH normal, hemograma formal sin esquistocitos y reticulocitos 2%, posiblemente Anemia inflamatoria. Dado VHS elevado y bicitopenia, se solicita estudio de Gammapatía Monoclonal con Electroforesis de proteínas, albúmina, proteínas totales, inmunofijación en sangre y recuento de Inmunoglobulinas, a realizar de forma ambulatoria.
9. Reumatología: se solicita IC a especialidad para evaluación de paciente dado antecedente de Vasculitis ANCA y posible compromiso neurológico actual. A equipo no impresiona Vasculitis activa, por lo que no tendría indicación de inmunosupresores. Se define mantener prednisona en dosis bajas, screening de gammapatía monoclonal y control con reumatología al alta.
10. Rehabilitación: Inicialmente con disfagia post IOT con buena respuesta a rehabilitación fonoaudiológica, logrando progresión a régimen común. Con KNT multimodal, logrando bipedestación y marcha independiente.
11. Profilaxis: Con tromboprofilaxis y profilaxis gástrica

LABORATORIO

11/01: Hb 7.5 Hto 21.2 GB 2970 Pla 212000 Alb 2.7 Ca .9 BUN 47.8 P 4.1 ELP 132/5.25/92 pH 7.46 PCO2 39 HCO3 27.5

Fecha Última Actualización: 11-01-2023 13:07:51

Página 3 de 5

10/01: Alb 2.8 Ca 8.5 BUN 28.8 P 4.4 ELP 135/5.58/93 pH 7.33 PCO2 56.7 HCO3 29.4 Hto 21.9 Hb 7.5 GB 3020 Pla 232000 Fierro 102 TIBC 155 UIBC 53 Sat transferrina 66% Ferritina 782.7 Reticulocitos 0.7% LDH 171 Frotis: poikilocitosis +, ovalocitos +
09/01: Hto 20.4 Hb 7.1 VCM 93.2 CHCM 34.8 GB 2470 Pla 232000 ELP 134/4.72//92 pH 7.42 PCO2 52.1 HCO3 33.6 Alb 2.7 Ca 8.8 BUN 39.3 P 6.3 VHS 81
06/01: Hb 8.2 Hto 24.5 GB 4190 Pla 216000 ELP 136/6.03/98 pH 7.32 PCO2 39.6 HCO3 20 EB -6 Alb 2.8 Ca 9.7 BUN 73.9 P 8.3 PCR 42.3 PTH 115
05/01: ELP 140/5.43/101, pH 7.37, PCO2 40.7, HCO3 23.3, Alb 2.9, Ca 9.8, BUN 58.9, P 7.8
04/01: Hb 8.5, GB 7300, RAN 5400, PLQ 216.000, ELP 141/5.19/99, Ca 9.4, BUN 80, P 10, PCR 49.4, pH 7.41, PCO2 36.7, HCO3 22.9
02/01: Hb 8.8, GB 6640, RAN 5000, PLQ 190.000, Alb 2.7, Ca 8.7, BUN 95.7, P 11.1, ELP 140/5.76/98, pH 7.40, PCO2 36.0, HCO3 22.1, LDH 253, PCR 72.0
28/12: Ác láctico 5.7 BT 0.21 BD 0.14 FA 71 Ca io 4.1 P6.3 Mg 2 CKt 111 CKMB 19 Crea 8.59 BUN 34.3 ELP 138/3.87/102 pH 7.456 HCO3 27.1 PCO2 39.4 PO2 130.9 Glucosa 106 PCR 142.5 GB 7.300 RAN 5.800 Hb 9 Pla 151.000
27/12: Crea 10.37 BUN 45.5 ELP 136/3.89/100 pH 7.436 HCO3 21.4 PCO2 32.5 PO2 96.5 Hb 8.9 Pla 123.000 GB 9.500 PCR 169.7 Ác láctico 5.5 Alb 2.5 Ca 7.5 (8.7) P 6.2 Mg 7 Glucosa 98
21/12: ANCA (-) ANA (-) Complemento normal
20/12: LCR: Claro, incoloro, células 2, prot 0.45, glucosa 65. Tinción (-); VZ/HS(-) Pendiente Cultivo.

MICROBIOLOGÍA

03/01: Cultivo rectal E. faecium Vancomicina R (+) S a Teicoplanina, Cultivo rectal carbapenemasas (-)
02/01: HC (-) UC (-), SOC Leucocitos 5-10 GR 50
27/12: CAET descartado, HC (-), Cultivo catéter (-), UC (-)
25/12 VHC/VHB NR VIH NR
23/12: CAET A. baumannii MS
20/12: LCR: Claro, incoloro, células 2, prot 0.45, glucosa 65 Cultivo (-)
18/12: PCR COVID (-) VIH/VHB/VHC NR OC no inflamatoria UC (-), HC 1 y 2 (-).

Imágenes:

·TAC TAP 18/12: Signos sugerentes de edema intersticial y alveolar pulmonar bilateral. Moderado derrame pleural bilateral con atelectasias parciales de ambos lóbulos inferiores. Signos de nefropatía crónica bilateral. Múltiples divertículos en colon izquierdo, sin signos de complicación actual.
·AngioTAC cerebral 18/12: Sin informe. Se describe por neurología en urgencias ¿Se observa hipodensidad subcortical cortical occipital bilateral sin territorio vascular, sugerente de PRES¿.
·TAC Torax 21/12: Leve a moderado derrame pleural bilateral, que no presenta cambios significativos en su cuantía respecto estudio previo, el que determina atelectasias pasivas de ambos lóbulos inferiores. Leve a moderado derrame pleural bilateral asociado a edema intersticial pulmonar bilateral, probablemente en contexto de sobrecarga de volumen. Contenido denso que rodea al catéter venoso central yugular interno derecho, que puede estar en contexto de un trombo pericatóter a este nivel. Signos tomográficos de anemia.
·TAC Cerebro 21/12: Sin informe. Impresiona "mismos signos sugerentes de PRES, en descenso"
·RM Cerebro 03/01: Pequeños focos de aspecto gliótico inespecífico en la sustancia blanca frontal bilateral. RM de cerebro sin hallazgos patológicos.

Diagnósticos actuales:

1. Insuficiencia respiratoria aguda global resuelta
 - 1.1. EPA hipertensivo + compromiso cuantitativo de conciencia
 - 1.2. IOT 19/12 ¿ 27/12 (reintubado)
2. Sepsis de foco respiratorio
 - 2.1. NAVM por A. baumannii MR tratada
3. Compromiso de conciencia en estudio
 - 3.1. PRES descartado
4. Sospecha crisis comicial, obs tóxico metabólica por hiperfosfatemia (resuelta)
5. Bicitopenia en estudio
 - 5.1 Anemia N-N obs inflamatoria
 - 5.2 Leucopenia
6. Hipertensión Arterial

Fecha Epicrisis : 11/01/2023 13:07

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 11-01-2023 13:07:51

Página 4 de 5

6.1. Retinopatía Hipertensiva grado 3 de K-W

7. Portación de E. faecium VanB.

8. Antecedentes: HTA, ERC en HD (FAV BI L-Mi-V, diuresis residual 250-500 ml/d), Vasculitis ANCA (+), Síndrome riñón-pulmón, Anemia secundaria

Diagnóstico de Egreso

Edema Pulmonar -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente HDN estable, en buenas condiciones generales, asintomático.

Plan Post Alta

Indicaciones al Alta:

Reposo relativo

Régimen hiposódico bajo en fósforo y potasio

Carvedilol 25 mg, medio comprimido cada 12 horas vo

Hidralazina 50 mg, 2 comprimidos cada 8 horas vo

Isosorbide 10 mg, 1 comprimido y medio cada 8 horas al día vo

Amlodipino 10 mg, medio comprimido cada 12 horas vo

Doxazosina 4 mg, medio comprimido cada 12 horas VO

Omeprazol 20 mg cada 12 horas VO (hasta 09/02 incluido)

Prednisona 5 mg, 1 comprimido y medio al día vía oral

Risperidona 1 mg SOS en caso de insomnio persistente

EICaID forte1 comp al día VO

Clonazepam 2 mg cada noche VO

Mantener fármacos de base

CONTROLES

Mantener hemodiálisis trisemanal, ya sea en Rengo o en Santiago según cambio de dirección

Control con Oftalmología equipo Retina, solicitar hora con esta Epicrisis en CDT.

Control con Otorrinolaringología para Nasofibroscopía, en 2 semanas, solicitar hora con Epicrisis en CDT.

Control con Reumatología con resultado de exámenes de sangre.

PENDIENTES

Tomarse exámenes de sangre: Electroforesis de proteínas en plasma, albumina, proteínas totales, hemograma + VHS y recuento de Inmunoglobulinas. Pedir hora en CDT con orden.

SOS

Acudir al S. urgencia en caso de dificultad respiratoria, tos con sangre, dolor torácico u otro motivo que considere.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Bajo En Sodio, Potasio Y Fosforo

Medicamentos :

Controles

Melisa Alison Reyes Lillo

Sebastián Oksenberg Sharim

Fecha Epicrisis : 11/01/2023 13:07

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 11-01-2023 13:07:51
BECADO Becado/Residente

Página 5 de 5
Médico Tratante (Staff)